

Krankheit	Anamnese/Symptome	Status	Prozedere/Untersuchungen	Therapie	Bemerkungen/Facts
Psoriasis vulgaris	Effloreszenzen, Juckreiz z.T., Nagelprobleme, Kopfhaut, Gelenksbeschwerden, i.d.R. Chron., Sonne hilft, FA <u>Auslöser</u> erfragen: Trauma! Medis (B-Bl., Lithium, ACE-H., Stress, Alk, Rauchen, Infekt, etc.), assoz. Erkrankungen (Hypertonie, DM, Crohn, Tumoren), FA	<u>Haut</u>: erythro-squamm. Plaques, silbergraue scharf-begr. Hyperkeratosen an Prädilektionsstellen (Streckseiten, Knie, Ellbogen + Reibeflächen >Rima ani),symmetrisch, meist scharf-begrenzt, Erythrodermie ev. Kerzentropfenphänomen (Schuppung), Ph. d. letzten Häutchens (BM löst s., fragile Haut), Ph. d. Trautropfens (Punktblutungen) <u>Nägel</u>: dist. Onycholyse, Ölflecken (gelb-weissl.), Grübchennägel/ Tüpfelnägel <u>Haare</u>: Haaransatz + retroaurikulär <u>Gelenke</u>: Arthritis psoriatica (radiol. ähnlich wie rA, aber betrifft Carpus, DIP, Daktylitis) <u>Zunge</u>: L. geografica	Biopsie ev., ev. Abstrich Schleimhäute nicht betroffen! <u>Beschreibung</u>: an Streckseiten multiple scharf-begrenzte teil erhabene erythrosquammöse plaqueförmige Effloreszenzen.	Leichte Ps.: Steroid-Creme (III/IV), Vit. D, Salicylvaseline*, Bäder*, ev. Teer- + Licht-Th Mittlere Ps.: PUVA, UVB, Retinoide Schwere Ps.: Immunsupr. (Metho., Cyclo.), Biologicals Ev. Psychotherapie! Patientenorganis. *zur Keratolyse (Harte Schuppen weg) Syst. Steroide KI weil Rebound! Vit. D: Hemmt Zytokine	Biologicals: TNF-a-BI. Immunsupr. Methotr., Cyclo.A Fam. Gehäuft z.T. <u>P. pustulosa</u>: sterile Pusteln <u>P. inversa</u>: Beugeseiten, Axilla, Nabel, anogenital <u>P. vulgaris</u>: klass. Psoriasis <u>Nach Grösse d. Herde</u>: guttata (einzelne Herde), nummularis (grössere Herde), geografica (grossflächig)
Ulkus cruris - venosum - arteriosum - diabetisch Andere: - dekubital - vaskulitis - lymphödem - infektiös - tumorös - pyod. gangrenosum	Ulkus (oft US), Dekubital, Alter <u>Art. Ulkus</u>: Wunde nach Trauma/Belastung die n. heilt, Rauchen, Dyslipid., DM, ev. Claudicatio/PAVK, Hochlagerung schmerzt <u>Ven. Ulkus</u>: CVI, Varizen, TVT, Ödemem, Hochlagerung lindert <u>Diabet. Ulkus</u>: DM, ev. Polyneuropathie, druckbelastete Stellen, oft Fuss Dekubital: Bettlägrigkeit	<u>Zeichen d. CVI suchen</u>: malleolär-medial, Ödem, Corona phl., Stauungsekzem (Exsikkose, Juckreiz (Stauungsekzem), Lipodermatosklerose,etc.) <u>Zeichen art. Ulkus suchen</u>: tibial-lateral, oft nach Trauma/Belastung, Zyanose am Ulkusrand, Hochlagerung sz.! <u>Zeichen diabet. Ulkus</u>: Druckstellen (Metatarsale-Köpfchen oft) <u>Neurostatus</u> (Sens., Mot., Reflexe, Vibration, Lage), <u>Gefässstatus</u>: Fusspulse, Rekap., Wärme, Auskult. <u>LK</u>	1. Abstrich (Infektausschluss), Biopsie (falls Ulkus >2-3 Wo.) 2. Art. Ausmessung/ABI + ev. US + Angiographie (art. /diabet. Problem), Venen-Duplex (ven. Problem) 3. Ev. RX/MRI (Knochenbeteiligung) 3. Interdisziplinär: Angio, Gefässchir., Derma, Innere/Diabet. *erst wenn Ulkus abgeheilt, vorher Kompressionverband (einbinden mit Salbe) ErgänzungTherapie: bei allen - AB falls Infekt - Chirurgie falls Osteomyelitis - ev. Vakuumverband - ev. Wunddeckung mit Spalthaut, Vollhautlappen od. autolog. Saugblasen	Venöser Ulkus 1. Kürettage, Salbe (Zinkleim), Kompressions-Verband 2. Behandlung Ursache: CVI - Kompressionsstrümpfe *(inkl. Hautpflege + Polsterung), Hochlagern, Bewegung, Medis, ev. Varizenops, RF's Arterieller Ulkus 1. Kürettage, Salbe, Verband 2. RF's therapieren (DM, Hyperto., etc.) 3. Medis (dilat. Medis: i.v. Prostacycline) 4.. Falls Gefäss-Stenose: PTA od. Bypass 5. Sobald Durchblutung ok: Kompression Diabet. Ulkus 1. Kürettage, Salbe, Verband 2. AB falls Infekt 2. Art. Durchblutung sanieren: PTA, Bypass 3. Chirurg. Falls Osteomyelitis 4. Druckentlastung/Spezialschuhe 5. DM einstellen	<u>Beginnt</u> oft mit Pusteln <u>Beschreiben</u>: Ulkus-grund, -rand + -umgebung <u>Typ.</u> U. venosum, arteriosum, art-venosum, anderer Diabet. Ulkus ist Unterform d. art. Ulkus, Ursache: Durchblutungsstörung od./+ fehlende Sens. Komplikationen - Infekt - Osteomyelitis - Ekzem - Keine Verschluss - Amputation

Trauma/Verletzung		Lymphgefäße (Lymph-Angitis) + LK, Sens./Motorik, Durchblutung,	Abstrich (Infektausschluss), Biopsie, BE, ev. Bildgebung	1. Wundversorgung : Spülen + Reinigung, Debridement, ev. Salbe, Verband 2. AB (i.v. od. ev. Salbe) 3. Tetanus-Rapell! Alle 20 J., ausser ab 65 J. alle 10 J.	
Akne	Effloreszenzen am Gesicht, Beginn Pubertät, Psyche erfragen (Folge d. Akne), FA (oft +)	Komedonen (schwarze Pünktchen als Primäreffloreszenz, offen od. geschlossen), dann Pusteln + Papeln + Knoten, dann Exkorationen, Narben.	<u>Formen</u> : A. comedonica (viele offene od. geschl. Komedonen), papulopustulosa (viel E.+ Eiter), conglobata (viel E. + Zysten), A. excoriata (bei jungen Frauen mit unreiner Haut Exkorationen ohne Komedonen oder Knoten), Acne fulminans (auf Boden A. conglobata ; Fieber, Leukozytose, Myalgien und Arthralgien), Hirsadenitis suppurativa (Vernarbung apokrine Drüsen), Medi-ind.	<u>Leichte A.</u> : top. Retinoide <u>Mittelschwere A.</u> : top. Retinoide + AB (top. od. syst.), Frauen ev. Antikonzeption <u>Schwere A.</u> : syst. Retinoide/Isotretinoin (als einzige Th., Roaccutan) od. AB bzw. Antiandrogene	Ohne Komedonen >keine Akne! DD akneiforme Dermatosen (Medis, Öl-/Teer, Chlor, Kosmetika, Sonne/Mallorca, etc.) Vor top. Th.: Haut waschen!
Hidradenitis supportiva / Acne inversa	Chronisch, Knoten, Narben in Regionen mit apokrinen Drüsen (Axilla, inguinal, perianal, gluteal, submammär), Frauen oft <u>RF</u> : Rauchen, Adipositas,	Nodulozystische akneartige Läsionen, Vernarbungen, keine geschlossenen Komedonen		Einzige kurative Th: Chirurgie Sonst: AB, syst. Steroide, Istotretinoin, Anti-TNFa	Def: Verhornungsstörung d. äusseren Wurzelscheide d. Terminalfollikels mit E. z.T. haben Pat. zusätzlich klass. Akne, Follikulitis, etc.
Rosacea	Effl. Gesicht, Veränderung Nase, Augenbeteiligung z.T. RF: Sonne, Alk, Kaffee, Stress, scharfes Essen, Temperaturschwankung	<u>Haut</u> : Erythem (zuerst Flush, dann persistierend), Papeln (z.T. Noduli), Pusteln, Teleangiektasien (Nase + Wange), Rhinophym <u>Augen</u> : auch beteiligt?		1. Topisch : AB 2. Systemisch : AB, Isotretinoin 3. Operation (Rhinophym) 4. Laser/Koagul. (Teleangiektasien) Ursache multifaktoriell.	DD SLE, Lupus Pernio/Sarkoidose, M. Wegener, Ekzem, Flush bei Karzinoid, Heliotrop. Erythem bei Dermatome. Keine Komedonen!!!!
Periorale Dermatitis	Jüngere Frauen, Effl. Gesicht,	Periorales + oft periorbitales Erythem mit Papeln + Pusteln, Aussparung um Lippen		So wenig wie möglich. Feuchte Umschläge, Thermalwasser-Spray. Tacrolimus , orale AB .	Nach top. Steroiden: Rebound.
Lupus Pernio	livide Infiltration von Nase, Wangen, Ohrläppchen. Innere Organe auch	Haut: Insp. + Palp. Internist. Status	BE (ACE-Konz. erhöht), Biopsie (Nackte Granulome)	Steroide, Cloroquin, PUVA	DD: SLE, Rosacea, M. Wegener, Ekzem, Flush bei Karzinoid, Heliotrop. Erythem bei Dermatome *

				*Grossknotige Form d. Sarkoidose	
Atopisches Ekzem / Dermatitis = Neurodermitis	Akut od. Chronisch, Ort, Aussehen, Beruf/Hobbies/ Auslöser/Tiere, Allergien, Juckreiz, FA, andere Atopien (Asthma/Rhinitis/ Konjunktivitis, Nahrungsmittelallergien), Beginn oft Kindesalter (Beginn meist als Milchschorf) Allergene: Pollen, Milben, Erdnuss, Milcheiweiss	Akut: Erythem, Bläschen, Nässe, Ödem, ev. Kratzspuren, meist Beugen betont Chron.: Erythem, Schuppung, Rhagaden, Lichenifikation, ev. Krusten, trocken, ev. Kratzspuren Kind: oft Herthoghe-Zeichen (Rarefizierung lat. A-Brauen) + Dennie-M-Falte (doppelte Unterlidfalte), Rhagaden an Ohrläppchen >Zeichen f. Atopie	1. Pricktest (Typ I) 2. Serologie (IgE) Exkurs: Ekzeme oft an Beugeseiten!	1. Allergen beseitigen 2. Steroidesalbe/creme, top. Calcineurininhib 3. Hautschutz (Trocken >Salbe, Nässend >Creme, E. >Steroidecreme/Salbe, infiziert >desinfizierende AB-Salbe) Falls Beruf: Handschuhe	In 20% IgE nicht erhöht! >Sog. Nicht-atopisches Ekzem (Symptome aber gleich) Sieht bei jedem anders aus! Oft Superinfektion >honiggelbe Krusten + Blasen!
Kontaktdermatitis - Allerg. Kontaktekzem - Irritative Kontaktekzem	Allergisch (Typ IV): akut od. chronisch, Auslöser /Allergien (Nickel, Farb- Duft-Konservierungsstoffe), Beruf/Hobbies/Tiere, Juckreiz, breitet sich aus Irritativ (nicht-allerg.): akut od. chron., Auslöser (Kontaktagens: Nassarbeiten, tox. Substanzen, mechanisch), Beruf, Hobbies, meist begrenzt auf Kontaktstelle	Akut: Erythem, Bläschen, Nässe, Ödem Chron.: Erythem, Schuppung, Rhagaden, Lichenifikation, ev. Krusten, trocken Exkurs Exsikkationsexkem: Trockene Haut/Exsikkose, mangelnde Hygiene, kaltes trockenes Klima können auch Ekzem machen >Hautschutz (Salbe!)	1. Patchtest (DD allerg./irritativ)	1. Auslösende Substanz weg 2. Steroidsalbe, top. Calcineurininhib. 3. Hautschutz (Trocken >Salbe, Nässend >Creme, E. >Steroidecreme/Salbe, infiziert >desinfizierende AB-Salbe) Falls Beruf: Handschuhe tragen	Allerg.. z.b. Leute die mit Nickel, Metalle, Duftstoffe, Konservierungsstoffe, Farbstoffe, gew. Instrumente, Schmuck, Kosmetika, Pflegeprodukte, Desinfektionsmittel.... Irritativ: Nassarbeiten, Tox. Substanzen, Teer, Öl, mechanisch, Säuren, Basen, Salze, Lösungsmittel, mechanisch >Coiffeure, Becker, Floristen, Gesundheitsberuf, Chemiker
Numuläres / mikrobielles Ekzem	Extremer Pruritus, intertriginös, perianal, Windeldermatitis, auch sonstwo möglich Trigger: Feuchtigkeit, Irritation, Mikroben	Kratzspuren, Exsudate, Krusten, ekzemat. Herde, z.T. Ulzeriert,	Verlauf: Chron.!	1. antimikrob. Bäder 2. top. Steroide 3. UV-Th. 4. Hautschutz (Trocken >Salbe, Nässend >Creme, E. >Steroidecreme/Salbe)	Exkurs: Exsikkationsexkem (trockene Haut, Alte, Winterzeit >Cremen + Hautpflege) Photoxisches Ekzem: s. phototox. Dermatitis Stauungsexkem: s. CVI
Seborrhoisches Ekzem	Schuppung Haut, Rötung, kein Juckreiz	Erythem, dicke Squammen →erythro-squammöse Hautveränderung oft an Haaransatz +Nasolabialfalte, Gesicht, Rücken, Brust, oft Beginn mit Kopfschuppung (z.T. fettig + nicht immer Rötung nötig), gelblich	Erwachsene 1. top. Steroide + Calcineurinihib. 2. antimikrob. Cremen + Shampoos 3. Salicylsäure (Keratolyse) 4. Isotretinoin (syst.) 5. Hautschutz (Trocken >Salbe, Nässend >Creme, E. >Steroidecreme/Salbe, infiziert >desinfizierende Salbe) Neugeborene: Zinkoxid-Creme, kurz top. Steroide mit antimyk. Zusatz		Oft bei Neugeborenen (innerhalb erste 3 Mte., meist innert 1. J. Spontanheilung, oft assoziiert mit Windeldermatitis) od. AIDS Bei Erw.: fettig-glänzendes schuppendes Ekzem

Chron. ven. Insuff. CVI	Ödeme, dunkle Verfärbung Haut, Induration, Ulkus ev. RF: TVT/Postthrombot. Sy., Varizen, BG-Schwäche, DM, Adipositas, Rauchen, Hypertonie, Dyslipidämie, Durchblutungsstörungen, Stehen/Sitzen	Im <u>Stehen</u> Venen untersuchen! Inspektion (Stauungsekzem, Ödeme, C. phlebectatica, Hypodermis/Pseudoerysipiel, Stauungspurpura, Hyperpigmentierung, Dermato-Lipo-Faszi-Sklerose, Atrophie blanche, Ulkus od. abgeheilt) + Palpation* <u>Art. Gefässstau</u> (art. Problem z.B. PAVK ausschliessen) <u>Neurostatus</u> (Polyneuropathie, DM, etc. ausschliessen)	BE (RF's), Venen-Duplex ev. mit Farbdoppler * Stadien nach Weber: Stadium I: <u>Ödem</u> , <u>Coronaa phlebectatica</u> (Besenreisser perimalleolär + paraplantar) Stadium II: <u>Hypodermis</u> (E. Haut, Pseudoerysipiel), <u>Stauungsekzem</u> (Nässen, Krusten), <u>Stauungspurpura</u> + -Jaune D'ocre-Purpura (Hämosiderin weil EC-Extravasate >braun), <u>Atrophie blanche</u> (Fibrosen weil Ischämie), <u>Dermatoliposklerose</u> (pralle verbackene Haut) Stadium III: <u>Ulkus</u> (ev. abgeheilt), auf Boden Dermatoliposklerose	1. Prophylaxe: Muskelpumpe/Bewegung, Hochlagern, Kompressionsstrümpfe* Kl. I-II reicht, kalte Dusche 2. RF's therapieren: Gewichtreduktion, Sport, Rauchstopp, Hypertonie-Th., Sitzen/Stehen vermindern 2. Medis (venöser Rückfluss), Daflon , Aspirin , Prostagl. E 3. Varizen-Ops falls Varizen: Crossektomie, Stripping, Miniphlektomie (Seitenast-V. + retikul. V.), Skleroth./Laser (Besenreisser)	*vorher art. Problem ausschliessen! <u>CVI:</u> Mikroangiopathie wegen Störung ven. Abfluss i.R. Varizen od. postthrombot. Sy.
Varizen/Krampfadern	TVT gehabt? Durchblutungsstörungen? Hypertonie, BG-Schwäche, Familie, viel Stehen/Sitzen	Im <u>Stehen</u> untersuchen! Stamm-, Seitenast-Varizen, Retikuläre V., Besenreisser (blaue od. rote) <u>Insuff. tiefes Venensystem</u> . Zeichen v. Postthrombot. Sy. suchen (schlechte Mikrozirkul.)			<u>Retikul. V.:</u> <3mm, subkutan, bläulich, netzartig (kosmetisch) <u>Besenreisser:</u> <1 mm blau, <0.4 mm rot <u>Crossektomie:</u> falls Insuff. d. 1. Klappe in Leiste wo Mündung ins tiefe V-System. F <u>Stripping:</u> bei Stammvarizen
Bullöses Pemphigoid	Starke schmerzhaft <u>Blasenbildung</u> , ev. Erosionen, Schleimhautbefall erfragen	<u>Bullöses Stadium:</u> Vesikel, Blasen, Erosionen, grossflächig oft, + Nikolsky-Phänomen (positiv meist nur bei Pemphigus vulgaris) <u>Nicht-Bullöses Stadium</u> (Dx. schwierig): ekzematöse + urtikarielle Läsionen, Prurigoknoten.....s. verschieden <u>Schleimhäute</u> (genit-anal-oral) untersuchen! >P. vulgaris beginnt oft an Mund-Mukosa (chron. Erosionen)	1. Abstrich + Biopsie + Immunfluoreszenz (sieht Ort d. Spaltbildung + AK-Ablagerungen (IgG und C3 bei Pemphigoid)) * <u>Pemphigoid:</u> Gesicht ausgespart, >70J. <u>Pemphigus vulg:</u> Beginn Gesicht/Mund, 40-70 J.	1. Top. Steroide 2. Syst. Steroide (Prednison) 3. Immunsuppressiva (Methothr., Tetracycl.) 4. Ev. i.v. Immunglobuline (Primär Kortison, dann kortinsparende Immunsuppressiva)	<u>Subepidermal:</u> Pemphigoid, P. gestationis, auch als obligate Paraneoplasie (andere AK); AK gegen BP 180/230 <u>Intraepidermal:</u> Pemphigus vulgaris; AK gegen Desmoglein 1+3 Pemphigoid häufiger mit zentralnervösen Krankheiten assoziiert (MS, Demenz, Parkinson)
Pemphigus vulgaris	BP: Juckreiz beim Alten PV: chronische enorale Schleimhautläsionen SS + Blasen: Pemphigoid gestationis!				
Dermatitis herpetiformis	<u>Juckende bzw. brennende</u> (nicht-schmerzhaft) Blasenbildung, Zöliakie erfragen (v.a. 30-40j. >jung!)	Gruppierte Papulo-Vesikel + Exkorationen, symmetrisch an Extremitätenstreckseiten + Gesäss	1. Abstrich, Haut-Biopsie + Immunfluoreszenz (Ig-A) 2. Serologie (IgG + IgA gg. Gewebettransglutaminase, Gliadin-AK) 3. Dünndarmbiopsie (Zöliakie)	1. Glutenfreie Diät (Remission) 2. Dapsone	Bullöse auto-immun-Dermatose (wie P. vulg. + Pemphigoid) oft mit Zöliakie + anderen Autoimmunpatholog. assoziiert! AK gg. Transglutaminase

Herpes Zoster	Sz.-hafte Vesikel, ev. Fieber, red. AZ Fragen ob Varizellen durchgemacht Trigger: Trauma, red. IS, HIV	<u>Haut</u> : Gruppierte Vesikel auf gerötetem Grund, Krusten (folgen den Vesikeln), dermatombezogen (bei Immunsupprimierten mehrsegmentaler Befall), z.T. gürtelförmig <u>Neurostatus</u> : Sensibilität (Dermatom) + Hirnnerven <u>Auge + Ohr</u> untersuchen: falls betroffen	Ophta-Konsil falls Auge betroffen 1. Abstrich (Bläschengrund) 2. Serologie (AK)	1. Antivirale Th. Valaciclovir* 2. Analgesie (NSAID) 3. Zink-Tinktur lokal (Wundheilung) *bei Alten auch noch 5-7 T. nach Sympombeginn um Risiko für postzosterische Neuralgie zu senken.	<u>Varizellen</u> : Juckendes Exanthem mit Bläschen, Pusteln, Erosionen, Krusten, Sternenhimmel, polymorph
Herpes labialis /in loco (sonstwo)	Fieberbläschen, Prodromi (Spannen, Sz., Kribbeln), Rezidiv, Sz. Trigger: Sonne, Stress, schwaches IS, Fieber	Gruppierte Vesikel auf gerötetem Grund, ev. Erosionen + Krusten, sz.-haft	1. ev. Abstrich (Bläschengrund) 2. Serologie (AK)	1. Desinfektion + Wundheilung (Zinksalbe) 2. Aciclovir, Valtrex (falls. Symp. n. länger als 3 T.)	Prophylaxe : falls 8-10 pro Jahr >low-dose Valtrex
Unterschenkelödeme	Ursachen erfragen: Herz, Niere, CVI, Leberproblem	Inspektion & Palpation, Internist. Status, Gefäßstatus	Ursachensuche : BE, RX-Thorax, US Niere + Leber	1. Hochlagern, Einbindung Beine, 2. Diuretika 3. Ursachen-spezifisch	
Kutanes T-Zell-Lymphom (Sézary-Syndrom oder Mycosis fungoides)	Effl. An Extremitäten, i.d.R. Keine Sz., kein Juckreiz, B-Symptome	Inspektion: stammbetonte fleckige Erytheme + Squammen, Plaques, z.T. Ulzerationen, Tumoren/Gewebepluss	Biopsie!!!	1. PUVA, Steroide, ev. Retinoide 2. Radio od. Chemo	Keine Heilung (Sézary 5-JÜR 10-20%) PUVA: Psoralen + UV CAVE: Erythrodermie!!!!
Hämangiom	Rötung, kein Juckreiz, nicht infiltrierend,	<u>Inspektion</u> : Rötung/Kapillarisierung <u>Spate!</u> : Rötung wegdrückbar (Unterschied zu Petechien welche nicht wegdrückbar)	Spateldruck (wegdrückbar)	1. Abwarten (oft Spontanheilung) 2. B-Blocker 3. Laser/Kryoth./Embolisation 4. ev. Steroide od. Chirurgie	Angeboren
Lichen ruber planus (Knötchenflechte)	Bds. Effloreszenzen, Juckreiz	Erhabene Papeln, Squammen, Papeln >erythemato-papulo-squammös, scharf begrenzt, homogen, symmetrisch, oft Beugeseiten Hand. + Unterschenkelgelenke		Steroide, Immunsuppressiva, PUVA	4 p: Pappel, purpur, polygonal, Pruritus (+Penis)
Exanthem	Plötzlich entzündl. Hautveränderungen, bestimmter zeitl. Dynamik (7-14 T. n. Medis od. 2-3 falls sensibil.), beginnt am Stamm, dann Extremitäten, Medi-Anamnese, Infekt-Anamnese <u>Trigger</u> : Medis, Infekte, Allergie, E., Nahrungsmittel	<u>Haut</u> : Grosse Hautbereiche mit roten Makulae + Papeln, ev. auch: Erythem, Purpura, Urtikaria, bei Medis konflierend, bei Infekten nicht konflierend <u>Schleimhäute</u> : falls Befall an * denken!!!! <u>Haut-Druck ausüben</u> : >Blasenbildung? Ja: Nikolsky-Phänomen <u>Infektfokus</u> suchen: LK, Mund-Rachen, Wunde	BE, ev. Abstrich/Biopsie Hospitalisation falls V.a. Lyell-Sy. (Medis) *Steven-Johnson-Sy, TEN od. Erythema exsudativum multiforme (harmlos), evtl. auch DRESS	1. Medi absetzen falls Medi od. Infekt behandeln falls Infekt 2. Falls Medi: Antihistaminika, Steroide (falls s. starke Reaktion) 3. Falls Medi Allergiepass	Nickolsky-Phänomen : Neigung Blasenbildung d. Haut

Arzneimittlexanthem	Angioödem/ Anaphylaxie od. eher Exanthem/TEN/etc., (genau erfragen was genau + zeitl. Dynamik >sofort- od. spättyp), Medis*, allerg. Symptome (bis Anaphylaxie), Allergien, FA <u>Urtikaria + Angioödem</u>: innert Min. bis Stunden nach Medi <u>Exanthem</u>: 7-14 T., falls sensibil. 2-3 T. nach Medi <u>DRESS</u>: 2-6 Wo. nach Medi <u>SJS/TEN</u>: 4 Wo. nach neuer Therapie	Soforttyp-Reaktion (Typ I): - Urtikaria: juck. flüchtige Quaddeln (<24h) ohne epidermale Komponente - Angioödem: Schwellung Lippen/Larynx/Augen/etc. + Juckreiz (2-3 T.) - Anaphylaxie** Spättyp-Reaktion (Typ IV): - Exanthem (meist juckendes MPE, Beginn Stamm, prox. Extremitäten) - DRESS (Gesichtsödem, Erythrodermie, exfoliative Dermatitis, Fieber, LK, Hepatitis, etc.) - Steven-Johnson-Sy. (sz-hafte brennende Makulae, Kokarden, stammbetont UND Schleimhäute, Blasen + Erosionen, Nikolsky-Ph., Exfoliationen, <10% d. KOF) - TEN (wie SJS aber >30% d. KOF!)	Soforttyp (Urtikaria + Angioödem) 1. Prick-Test 2. Serologie (IgE) Spättyp (DRESS, SJS, TEN, etc.) 1. Hospitalisation 2. PVK, BE (Eosinophilie + atyp. LZ bei DRESS) 3. Lyphozytentransformationstest LTE 4. Patch-Test Oft Hospitalisation	<u>Urtikaria/Angioödem/MPE/DRESS</u> 1. Medi absetzen 2. Antihistaminika 3. Top. od. syst. Steroide (falls s. starke Reakt.) <u>Anaphylaxie</u>: Adrenalin i.m., Antihist., Steroide <u>SJS/TEN</u> 1. Steroide syst., Ciclosporin, IgG i.v.	*Soforttyp: B-Lactam-AB, NSAID, Kontrastmittel, LA, ACE-Hemmer Spättyp: vorherige+auch Antiepileptika, Allopurinol, u.a. **Dyspnoe, Schwäche, Bewusstseinsstrübung, Atem- + Kreislaufstillstand <u>Zeitl. Dynamik</u>: Spättyp Tage nach Medis, Soforttyp Min. bis wenige h. DD: Erythema exsudativum multiforme! >tritt oft nach Infekt ein, ähnlich wie SJS/TEN aber begrenzt auf Akren/Hände/Lippen/Mund, nicht am Stamm, harmlos!!
Dermatitis solaris / Sonnenbrand	Erythem 6-24h nach Sonnenexposition	Homogenes nicht-erhabenes Erythem an sonnenexp. Stellen	Viel Sonnencreme (>15 + mit UVA-Schutz, 30 min. vor Baden), Sonnenbrille mit UV-Schutz, Hut, keine Mittagssonne, Kleinkinder keine Sonne, Kleidung, etc.	1. NSAID (ASS od. Indometacin) 2. Kühlende Kompressen 3. Steroidhaltige Lotionen	Prophylaxe*
Polymorphe Lichtdermatose / Sonnenallergie	Polymorphe Effloreszenzen nach Stunden bis 1-2 T.) Sonnenexp.: bei jedem anders, i.d.R. Besserung im Verlauf d. Sommers	Polymorphe Effl., bei jedem Pat. aber immer gleich!	Lichttreppe Photoprovokation Photopatch-Test	1. Starker Sonnenschutz (v.a. UVA) 2. Hardening (s. daran gewöhnen) 3. Steroide lokal, ev. Antihist.	Meist chron.-rezidiv.
Solare Urtikaria	Quaddelbildung innert Min. nach Sonnenexpos. an sonnenexp. Arealen	Urtikariae	Lichttreppe Photoprovokation Photopatch-Test	1. Antihistaminika 2. Sonnenschutz 3. Hardening	Gehört zu den physikal. Urtikariae
Phototoxische /Photoallerg. Dermatitis	Akutes Erythem an sonnenexponierten Arealen Trigger/Auslöser: Medis i.d.R., Pflanzen/Gräser, Parfums, etc.	<u>Phototoxisch</u> : streut nicht, nur sonnenexp. Areale, Pigmentierung postläsionär <u>Photoallergisch</u> : streut, Kinn- + retroaurikuläre Aussparung, leichte Latenz	Lichttreppe Photoprovokation Photopatch-Test	1. Trigger beseitigen 2. Antihistaminika falls photoallergisch 3. Kühlende Kompressen	<u>Photoallergisch</u> : Sonne wandelt Substanz/Trigger in Hapten um >allerg. Reaktion <u>Phototoxisch</u> : Substanz ist phototoxisch >macht Haut photosensitiv >Sonne wirkt dann schädlich >Erythem
Chronische aktinische Dermatitis	Chronisch, Ekzemartige Läsionen an Lichtexponierten Arealen, Ältere Männer oft	Ekzematoide Läsionen + Lichenifikation + Exkoration, v.a. lichtexp. Areale, Maximalform: aktinisches Retikuloid (Gefahr kut. T-Zell-L.)	Lichttreppe Photoprovokation Photopatch-Test	1. Immunsuppressiva 2. ev. Hardening /Exposition	Chron. E. d. Haut mit Photosensitivität >unterhalten durch UVA + /od. -B

Porphyria cutanea tarda	Effloreszenzen an lichtexponierten Arealen, Haarwachstum, Pigmentierung, etc.	Blasenbildung (subepid.), Hypertrichose an lichtsensiblen Arealen, Hypo- + Hyperpigmentierungen, Hautfragilität	*In der Haut eingelagerte Porphyrine reagieren phototox. auf Licht >Blasen, etc. Nicht nur Haut, auch Leber, etc. betroffen BE, Biopsie	1. Trigger meiden 2. Aderlaesse (damit keine Eiseneüberladung) 3. Chloroquin (Porphyrinausscheidung steigt) 4. Lichtschutz	Überschuss an Porphyrinen weil autosom.-dom. Enzymmangel (Leber). Falls Triggerfaktoren + Licht* >Symptome
Telogeneffluvium	Diffuser Haarausfall, Mangel (Fe), metabolisch (Hypo- + Hyperthy., Prolaktinom, etc.), Postpartal, Stress (Infekte, Fieber, Ops, Narkose), Systemerkrankungen, Medikamente, chron.-idiop.	Diffuser Haarausfall (erkennt man i.d.R. erst wenn 25-50% ausgefallen) Haar-Anamnese allgemein Brüchigkeit, Haarausdünnung, ungenügende Haarlänge, zu starkes Haarwachstum, herdförmig od. diffus, Medis, Stress, Psyche, Hormone	BE (Mangel), Abstrich (falls Ulzera, etc. >Infekt-Ausschluss), Biopsie (falls V.auf vernarbende Alopezie: SLE, etc.), Pulltest, Trichogramm (Haarwurzel-Stadium)	1. Falls Ursache bekannt beheben 2. L-Cystein - + Biotin präparate 3. Medizinalhefe (unklar)	Haare gehen zu schnell in Telogenphase DD: diffuse Form d. Alopecia areata DD: androgenet. Alopezie (langsamer Effluvium, bei Männern frontaler Beginn, Frauen Scheitel)
Alopecia areata/kreisrunder Haarausfall	Kreisrunder Haarausfall od. auch diffuse Form möglich, ganzer Kopf/Körper od. nur regional, +FA,	rundovale nicht-vernarbende Alopezieherde, Epilierbarkeit ⚡ (+ Pulltest >kann Büschen rausziehen), auch Wimpern/Brauen/Bart/K-Haare möglich, ganzer Kopf/Körper kann betroffen sein! Grübchennägel u.a, Nachwachsen v. weissen Haaren (Typisch)	Biopsie	1. Spontanremission (50%) abwarten 2. top. Steroide 3. top. Immunth. mit Allergenen (stimul. Haarwuchs) 4. syst. Steroide	Autoimmun, fam. gehäuft, jedes Alter möglich, m = f, oft Rezidive Falls vernarbend: diskoider Lupus, schlimme Fälle Tinea capitis
Übermässiger Haarwuchs	FA, endokrine Störungen, Medis	Hypertrichose : oft ganzer Körper stärker behaart, aber auch nur regional möglich (nicht auf androgen-sens. Areale beschränkt) Hirsutismus : nur androgen-sensitive Areale stärker behaart (männl. Verteilungsmuster) Virilismus : Hirsutismus + Vermaennlichung v. Organen	BE (Hormon: Testosteron, FSH, LH), Gynäkolog. Untersuchung, NNR-US	1. Grunderkrankung 2. Epilation/Laser 3. Antiandrogene	
Pilzinfektion Haut	Effloreszenz, meist einseitig, Grösse nimmt zu, Juckreiz Trigger: Tierkontakt, Bäder, Feuchtigkeit, schwaches IS	einseitig, randbetont, schuppig, zentrifugal ausbreitend, rundlich, rötlich, wenig E-Reaktion, Juckreiz, oft Nach Tierkontakt Tiefe Mykosen : v.a. Follikel/Haare betroffen, starke E., Infiltration, LK, Einschmelzung Haarfollikel/Alopezie, Superinfektion	Entnahme Schuppen > Präparat/LM (Kalilauge-Nativ, Färbung, Gram), Biopsie (Hautstanze) >Kultur *weisslich-astreifbare Beläge auf rötlich-erosiver Haut/Schleimhaut, lokale AM **oberfl. Infektion mit	<u>Oberflächliche Mykose</u> <u>Lokales Antimykotikum</u> <u>Tiefe Mykose</u> Syst. Antimykotika + ev. lokal Abszessdrainage falls nötig Generell: falls starke E. >schwaches Steroid dazu geben	<u>Tiere</u> mitbehandeln falls Ursache! <u>Formen</u> : oberfl. od. tiefe Mykose, Candida-Mykose*, Pityriasis versicolor (rubra + alba)** , Pityosporeon Follikulitis***
Nagelpilz/ Onychomykose	Weissliche Veränderung, ev. Ablosung Nagel Trigger: Feuchtigkeit/Bäder, Trauma, enge Schuhe, Alter, DM, schlechte	Weissliche krümelige Massen unter Nagel, Verdickung Nagel, Farbveränderung, falls Matrix befallen Wachstumsstörung, ev. Ablösung Nagel	Pityrosporon ovale, v.a.am Stamm, weissl.-depigment. (alba-Form, sieht man im Sommer gut) od. rötlich-bräunl. (rubra Form, Winter) Herde, Schuppung nach	1. Antimykotika (Terbinafin /Lamisil, Itra- od. Fluconazol) Systemisch viel bessere Resultate als Lokal (dann Entfernung d. betroffenen)	Th. i.d.R. erst sobald <u>Erregernachweis</u> (Kultur), falls aber starke Symptomatik empirisch mit AM beginnen + Kontrolle in 1 Wo., falls keine Besserung umstellen auf Steroid (dann liegt wohl kein Pilz)

	Durchblutung, schwaches IS, etc.		Kratzen; Shampoo + lokale + syst. AM	Nagelanteile nötig)!	vor).
Pruritus/Juckreiz	<u>Dimensionen</u> gut erfragen: Qualität (Brennen, Kribbeln, Prickeln, Ameisenlaufen), verstärkende(lindernde Faktoren, VAS, Beginn/Dauer, etc. Kratzverhalten <u>Trigger</u> : Dermatoze, Allergie, Medis, internist. Erkrankung, Psychiatrisch/Stress, neurogen, SS	<u>Haut</u> : Inspektion + Palpation, Effloreszenzen? <u>Internist. Status</u> <u>Psychostatus</u> bei Verdacht * Nägel schneiden, Haut salben (od. cremen), Stress meiden, Entspannung, synthet. Stoffe meiden, Kühlen	Allergie-Abklärung Medis ev. ändern Internist. Ursache* suchen: BE + Serologie (Parasiten), Bildgebung (Rx-Th, CT-Abd.) Neuro- od. psychiatr. Konsil *Dialyse, Leberpathologien, Pankreas, Tumoren (Polyzyt. Vera, Sezary Sy., M. Hodgkin), Hyper/Hypoth., HIV, etc.	1. Ursache therapieren 2. Hausmittel* 3. Symptomatisch - Topische Creme/Salbe: Doxepin/TCA, Capsaicin, Methol, Steroide falls auch E. - Systemisch: Antihistaminika, Mastzellstabilisatoren, SSRI , Opioid-Rez.-Antag. (Naltrexon), UV , etc.	Viele <u>Mediatoren</u> beteiligt, Antihist. allein i.d.R. nicht genügend. <u>Salbe</u> wäre gut bei trockener Haut, wird aber oft wenig gemocht v. Pat., daher meist Creme. <u>Psychogener Pruritus</u> : oft an komischen Stellen (Vulva, Ohr, Scrotum, Mund, etc.)
Prurigo	Schubweise, Exanthem, Juckreiz, chronisch, Haut aufkratzen weil so starker Juckreiz, Kratzen führt zu Bibeli, Frauen mehr, oft um Menopause	Exanthem mit stark juckenden Papeln, Kratzartefakte, Krusten (z.T. hämorrhagisch), Aussparung Rückenmitte, sek. Infektionen, Narben	Dx via Klinik + Anamnese, andere Dermatosen ausschliessen	1. Kratzen verhindern 2. Okklusionsverband 3. Top. Steroide, Capsaicin 4. Kryotherapie, UV, Laser 5. Psych. Therapie	Durch Kratzen induzierte Papeln >Juckreiz >Pat. bewirken chron. Dermatoze durch chron. Kratzen
Lichen simplex/vidal	Juckreiz, Vergrößerung Hautrillen, chron.	Vergrößerung Hautrelief/Lichenifikation >sieht grobe Rillen			Lichenifikation d. Haut mit starkem Juckreiz.
Urtikaria	Spontane U. : Dauer (akut, chron.), Effloreszenzen, Juckreiz, Reisen, Beruf, Hobbies, Stress, Angioödem <u>Trigger</u> : Medis, Infekte, Allergien inkl. Nahrungsmittel, Insektengift Physikal. U. : Factitica/Druck, Kälte, Wärme, Licht Andere U. : cholinerge, Kontakt, OAS	Spontane U : Multiple Urtika (mit zentralem Ödem + erythemat. Randsaum, keine Schuppung, flüchtig, keine Exkorationen), ev. urtikarielle Dermographismus U. factitia : Kratzen, Reiben löst Urtikae aus >urt. Dermographismus Pyhsikal. U : Urtikae <u>Exkurs</u> : Orales AS = sepzielle Form der Kontakturtikaria. (Juckreiz bei Kreuzallergenen)	<u>Akute U</u> : keine Biopsie ausser wenn Urtikae >24h, keine Diagnostik (ausser bei V.a. allerg. Genese >allerg. Abklärung) >zuwarten, heilt in 99% spontan ab <u>Chron. U</u> : Biopsie, BE, BSG + CRP, je nach Anamnese/Befund <u>Physikal. U.</u> : Provokation zur Dx	<u>Alle U.-Typen</u> : Antihistaminika! (bis 4-fach) <u>Akute U</u> : zusätzl. syst. Steroide falls starke Reaktion (Anaphylaxie, Larynxödem) <u>Chron. U</u> : AH (1-3 Mt.), falls keine Besserung: LT-Antag., Immunsuppr., Omalizumab*	<u>Einteilung</u> : Spontane U: Akut <6 Wo, sonst chron. Cholinerge U: U. durch Anstieg Körpertemp. Kontakt-U.: durch Kontakt mit allerg. Od. nicht-allerg. Substanzen *Anti-IgE-Ak
Hered. Angioödem	Rezidiv. Angioödem: Schwellung - Schleimhäute + Atemwege (Larynx-Ödem, ohne Th. in 25% tödlich), urtikarielle Veränderungen Haut - Schmerzen - Kein Juckreiz, keine Urtikaria	<u>Schleimhäute</u> : geschwollen <u>Haut</u> : geschwollen/Ödeme (in tiefer Dermis Subkutis, Urtikaria nur in Dermis) <u>Respirationstrakt</u> : Gefahr Larynx-Ödem	Ev. Atemweg sichern, BE I.d.R. Spontaerholung nach 72h (Urtikaria nach 24h falls akute U.)	<u>Akut</u> : C1-Inhib. -Substitution <u>Prophylaxe</u> : Danazol (regt Leberstoffwechsel an), Tranexamsäure , bald rekomb. C1-Inhib.	Ödem d. tiefen Dermis + Subkutis + Submukosa weil Mangel an C1-Inhibitor >zu viel C1-Esterase Falls C1-Esterase-Inhibitor ok, meist Faktor XII Mutation (Frauen, Östrogen-abh.)

Vaskulitis - <u>Grosse Gefässe</u> : Riesenzellart./M. Horton/A. temporalis + Takayasu-Art. - <u>Mittlere Gefässe</u> : Panart. Nodosa - <u>Kl. Gefässe</u> : P. Schönlein-H., Leukozytoklast. V.	Ausdehnung, nur Haut? Ursachen: Infekte, Medis, auto-immun, Tumoren, idop.	Palpable (n. wegdrückbar!)>Diaskopie/Spatel) Purpura (Petechien, Ekchymosen), ev. Nekrosen/Knoten/Urtikae/Pusteln, Livedo (i.d.R. racemosa) Je tiefer desto stärker/tiefer E. <u>Oberflächliche E</u> : fixe Urtikae, Plaques <u>Oberfl. starke E</u> : Purpura, Papeln, Bullae <u>Tiefe E</u> : Papeln, Livedo racemosa, Nekrosen	BE (ANCA- vs. nicht-ANCA-assoziierte V., ANA, Kryoglobuline, Anti-PL-AK, Kreatinin, Harnstoff, Eosinophile etc.), tiefe Haut-Biopsie, U-Status, Thorax-Rx <u>*Vaskulitis-Simulatoren (DD)</u> Antiphospholipid-Sy, Kumarinnekrose, Kryoglobulinämie Typ I, Cholesterinembolien	1. Bettruhe /Hospital. 2. Kompression (Läsionen an Extremit.) 3. Medis - Neutrophile hemmen (Dapsone , etc.) - Immunsuppre. (Steroide, Methotrex....) - Antikoagul. (falls Thrombosen/Embol.) 4. Auslösende Faktoren beseitigen	<u>Livedo</u> : livide Hautverfärbung (weil PO2↓) * <u>ANCA-assoziierte Vaskulitiden</u> : M. Wegener (c-ANCA), Mikroskop. Polyangitis, Churg-Strauss (p-ANCA)
Sklerodermie	Haut (falls kutane Form): Verhärtungen Haut, Atrophie, Sz., Amimie <u>System. SD</u> : Multiple Symptome je nach Organbefall, oft Beginn mit Raynaud-Sy.	Inspektion Haut falls kutane SD: Roetung/Oedem >Fibrose >Atrophie/Fibroseplaques an Akren + Gesicht oft, Amimie, verkürztes Frenulum, Mikrostomie, Onycholyse, Fingerkuppenulzera <u>Internist. Status</u> (falls syst./diff. SD)	BE (AK-Nachweis), ev. Biopsie	Top. Steroide , syst. Steroide + Chloroquin , UV-Therapie	Formen: Diffus/Systemisch (schnell fortschreitend, anti-scl70), lokalisiert/zirkompstripte/ Morphea, CREST-Sy (langsam fortschreitend, anti-Zentromer-AK)
Dermatomyositis	<u>Haut akut</u> : geschwollene Lider + Handrücken, Hauteffl., Juckreiz, Photosensibilität <u>Haut chron</u> : Papeln, etc. (s. re.) <u>Muskeln</u> : Muskelschwäche + -schmerzen(v.a. Schulter- + Hueftguertel, Kaemmen, Treppensteigen schwierig) <u>Internistisch</u> : Fieber, Herz-Insuff., GIT, etc.	<u>Inspektion Haut</u> <u>Akut</u> : odemat. Erythem (Augenlider, Handruecken + periungual), Hauteffl. (Odeme, Blasen, Papeln) an Gesicht/Hals/Schulter/Knie/Kopf/Gesaess/lat. OS, Hände, kutikul. Hyperkeratose (Nägel) <u>Chron.</u> : Lichenoide Papeln, Hyperkeratose, Teleangiektasien, Atrophie, Kalzinose Neurostatus : Muskelkraft, Sens., Motorik, Reflexe Internistischer Status	Labor (AK, Muskelenzyme falls Muskelbefall >CK, LDH, Aldolase), Biopsie, MRI (falls starker Muskebefall nur)	1. Schutz vor Licht (Faktor 30) 2.. Steroide 3. Immunsuppressiva (Tacrolimus, Methotrexat) 4. Chloroquin	Frauen > Öfter im Frühling
Pyoderma gangrenosum	Trigger: Insektensteiche, Trauma	Grossflächige Ulzera + Nekrosen (Gangrän) Haut	Biopsie	Immunsuppressiva, Steroide (keine AB, keine Chirurgie)	<u>Ursache</u> : nicht-infektiös, whschl. Überreaktion IS, assoziiert mit inneren Erkrankungen (Crohn, Leukämie, etc.)
Epizoonosen	Anamnese : Tierkontakt/Haustiere, enger Kontakt mit Menschen, Umfeld, Fieber, Stichstelle, Juckreiz, Schwellung, Natur, Hobbies, Gewässer/Meer, Urlaub Pediculosis capitis : Läuse, Nacken + retroaurikulaer: starker Juckreiz, urtikarielle Papeln, Kratzspuren, ev, Impetigo, LK nuchal, Kot/weisse n.-abstreifbare Nissen/Eier an Haaren; Pediculosis vestimentorum : Kleiderläuse (Naehete!), v.a. Verwahrloste, selten, Juckreiz/Quaddeln/Papeln/Kratzspuren >am ganzen Koerper (DD zu P. capitis),			Untersuchungen/Tests <u>P. capitis/Vest./pubis, Cimicosis, Pulicosis</u> : Nachweis Nissen/Kot <u>Insektenstich</u> : ev. Test auf Allergie (Prick- + Patchtest) <u>Skabies</u> : mikroskop. Milbennachweis <u>Zeckenbiss</u> : Serologie ev., LP (V.a. FSME/Borreliose), ev. Biopsie zur Dx Therapie	

	Pediculosis pubis: Filzläuse (Laese genital, axillaer, bart, wimpern), via Sex od. engen Kontakt (Kind-Eltern) od. Bettwaesche, Maculae cerulae/blau Flecken (=Bisse) typisch Pulicosis: Tierflöhe>Menschenflöhe, Juckreiz, erythro-urtik. Läsionen, bedeckte Körperstellen Cimicosis: Wanzenbefall, morgendlicher Juckreiz (typisch), papulo-urtikarielle Läsionen mit zentraler Bissstelle, oft lineare Strassen (Wanzenstrasse), Spatel: zentral-haemorrh. Punkt Myiasis: Rote Papeln/Knoten mit zentralem Loch (Atmungskanal) Skabies: Milbenbefall Haut/Kraetze, laengliche strichfoermige Laesionen (oft genital + axillaer, Papulo-Pusteln), Juckreiz bei Bettwaerme, Milbengänge, Haende/Fuesse/Gesicht frei (ausser Saeuglinge) Zecken: Erythema chronicum migrans (scheinbenfoermiges Erythem wo Biss, T.-Wo.), Lymphozytom (oft Ohrlaepchen, Mamille, Genital, Rumpf), Acroderamitis chronica atrophicans (Spaetstadium), Neurostatus, Fieber/Kopf-Sz./Arthralgie Bienen-/Wespen-/Hornissenstich: lokale Schwellung/Quaddel+ Rötung, Sz. Larva migrans: v. Pferdebremsen od. Hakenwuermer aus Hund-/Katzenkot dringen in Haut >entzuendeter Gang, Juckreiz, Fusskante oft; Urlaubsdermatose (Afrika, Karibik, Mittelmeer!) Zerkardiendermatitis: Trematoden/Saugwuermer dringen irrtuemlicherweise in Menschenhaut + werden zu Larven + Wuermer, Rötlicher Gang (seröse gefüllt), Juckreiz nach Baden (klass. Sympmt.)		P. capitis: Lausegift/Insektizid-Shampoo (Permethrin u.a.), Dimeticon (Silikonpraep./natuerlich), Essigwasser, Laesekeemme, antipruriginose Th; Kontaktpersonen! P. vest.: „“ P. pubis: Permethrin-Creme, tgl. Waeschewechsel, Kontaktpers. Pulicosis: Entwesung, anti-Juckreiz-Th, Kontaktpers., Einreibung Insektenabweisung Cimicosis: Entwesung Räume/Möbel Myiasis: Rausdrücken Larven, Desinfektion Skabies: Waeschewechsel + Auslueften, top. Steroide, ev. Permethrin (Kinder), Vollbad mit Antiseptikum, Antihist., ganze Familie! Zecken: Entfernung + Desinfektion, falls Borreliose-Sympt. AB (Doxycyclin) Bienen/W/Stich: Kuehlung, Salbe, bei Allergie Steroide/ Antihistaminika/Adrenalin L. migrans: Tibendizin (Fungizid) Z-Dermatitis: symptomat.
Venerologie	Geschlechtsverkehr (oral, anal, vaginal), wechselnde Partner, Verhütung, Prostitution, Treue (Partner), Ausfluss, Juckreiz, Ulzera, Sz., Dysurie, B-Symptome, SS, etc. Untersuchungen:* BE, Abstriche/Serologien/ HIV-Test, SS-Test, Biopsien: Syphilis >Serologie (Dunkelfeldmikroskopie), Chlamydien + Gonorrhoe >Abstrich + ev. Serologie, HIV >Serologie/ PCR (RNA), CD4-Zahl, HPV > Biopsie (Zytologie bei Zervix-Dysplasie), H. genitalis >Serologie (meist Klinik!)	Syphilis/Lues: sz-loser <u>Ulkus</u> 2-3 Wo. p.i. (anal/genital/oral, kontagiös!), <u>Makulo-papul.</u> Exanthem auch palmoplantar (typisch!), buntes Bild möglich, bei Neurosyphilis (progr. Paralysen, Pers-Veränderungen, etc.) Gonorrhoe/Tripper: purulente <u>Urethritis</u> (vor 1. Miktion morgens Eitertropfen), Maenner (Epididymitis, Prostatitis, Pharyngitis, Proktitis (anal)), Frauen (Zervizitis, Salpingitis, PID), ophtalmia neonatorum beim NG falls Infektion bei Geburt Chlamydien: ähnlich wie Gonorrhoe HIV: oft <u>asympt.</u> Infektion, <u>grippale Symptome</u> (subfebril), general. pers. <u>Lymphadenop.</u> (v.a. extrainguinal), Sympt. eines schwachen IS (Candidosen, Condylome, H. Zoster, chron. Diarrhoe, Fieber, etc.), <u>opport. Infekte</u> u.a. (EBV, HPV, Pneumocystis carinii-Pneumonie PCP, chron. HSV-Ulzera, TbC, Kaposi-Sarkom, HIV-Enzephalopathie, atypische Dermatosen, etc.) HPV: <u>Verrucae vulgares</u> (klass. Warzen/Papillome an Haut, beetartige Aussaat, low-Risk HPV-Typen, falls s. flach ><u>V. plana</u>), <u>Verruca plantaris</u> (Klass. Fusswarze: Dorn- od. Mosaikwarze, Hautrillen dort unterbrochen + Punktblutungen), <u>Condylomata acuminata</u> (sexuell-uebertragte anale/genitale Papillome/Warzen/Feigwarzen, falls flach <u>C. plana</u> >oft bei Cervix + Vorhaut), <u>Buschke-Lowenstein</u>-Tumor (Riesencondylome, gilt als verukoeses Ca), <u>M. Bowen</u> (onkogene HPV 16/18, gilt als Ca in situ, auch extragenital möglich), <u>Erythroplasie de Queyrat</u> (Ca in situ, nur genital, onkogene HPV), <u>Zervix-Dysplasie/Ca</u> HIV + Haut: Xerosis cutis, Psoriasis vulgaris, Hyperpigmentierungen, Purpura/Petechien, papuloese Dermatitis (viele kl. Papeln auf trockener Haut), eosinophile Follikulitis (extrem juckende!!! Papeln + Pusteln an Gesicht/Nacken/Rumpf/Extremitaeten), Aphten, seborrh. Dermatitis (s. haeufig! schuppiges Ekzem ohne Talgprod.) H. genitalis: HSV-II (selten I), asypt. Infektion oft, dann sys. Infektzeichen, Dysurie, Lymphadenopathie, Ulzera, oft s. schmerzhaft, Superinfektionen, Disseminationsgefahr	Syphilis: Depot-Penicillin-Spritze Gonorrhoe: Ceftriaxon (wenn Kombi mit Urethritis Ciprofloxacin, wenn Co-Infektion mit Chlamydien Azythromycin und Doxycyclin) Chlamydien: Doxycyclin HIV: HAART HPV: <i>Verrucae vulg./plant./plana</i> >Keratolyse, Kryoth. (bei plantaris nicht), Bleomycin, kauterisation, Laser, keine Chirurgie!. Condylome: Podophyllotoxin, Imiquimod/Aldara, Laser, Kauterisation. Kinder meist Spontanheilung) H. genitalis: Aciclovir (max. 3 T. p.i.), Analgesie, Desinfektion *ein Praxis via Präparate einfach diagnostizierbar: Gonorrhoe, Chlamydien, Syphilis, Pilzinfekte/Candida, HSV, HPV
Bakt. Hautinfekte	Erysipel (Dermis): akute E., scharf begrenztes Erythem, Schwellung, Sz., Überwärmung, schlechter AZ, Fieber, Schüttelfrost, Eintrittspforte suchen. RF: DM, CVI, Lymphödem Phlegmone /Cellulitis (Dermis + Subk.): unscharf begr., teigige schmerzhaft Schwellung, lividot Blasen, Nekrosen, red. AZ Lymphangitis (Lyphgef.): akut, Lymphweg gerötet linear Nekrotisierende Faszitis (Faszien): starke Sz., Schwellung, schnelle Progression, sept. Schock Follikulitis: Kopfhaut, Gesicht, Rumpf, follikulaer-gebundene Pustel mit rotem Saum, eintrige Krusten Furunkel/Karbunkel (konfluierende Furunkel): tiefe Follikulitis (oft wo Druck/Gesäss), akut, sz.-hafte Knoten, Einschmelzen, nekrot. Pfropf. RF: DM, Immunsuppr.	Anamnese: Eintrittspforte, DM, Ödeme, Fieber, AZ, Sz., Untersuchungen: BE (CRP, Hämat., LK), Abstrich, Präparate (Nativ, Gram), Kultur anlegen +Resistenzlage	Erysipel: syst. AB (Penicillin), Kuehlung, Ruhigstellung Phlegmone: Breitband-AB, „“ Lymphangitis: AB Nek. F.: Ops, AB Follikulitis: Desinfektion Karbunkel: AB (falls Fieber + s. gross), Inzision (im Gesicht KI), Hygiene I. contag.: Penizilline p.o., Desinfektion,

	Impetigo contagiosa: oberfl., Vesikel (selten gross-bullös),dann honig-gelbe Krusten, kontagiös, Erosionen, Paronychie/Bulla repens/Umlauf: akut, Rötung + Schwellung Nagelbett, DM Panaritium: akut, Rötung, Schwellung Finger Lepra: trockene Haut, Anhidrose, Alopezie, Anästhesie, Hypopigmentierung, tuberkuloid od. lepromatöse Form			Status: LK! Eintrittspforten suchen, Haut	Hygiene Umlauf: antimikrobiell lokal Panaritium: ev. Inzision, Desinf. Lepra: 3er-Chemo-Th. , Reha
Kutane Lymphome	Mucosis fungoides (T-Zell-L.): Patch (rötl. Maculae mit hellen Arealen/Nappes Claires)-Plaque-Tumor (z.T. Ulzera) –Erythrodermie; LZ in Epid./Epidermotropismus/Lining-Up; Sézary-Sy (T-Zell-L.): chron. Erythrodermie, Pruritus , LK, palmoplant. Hyperkeratose; Sézary-Zellen (Hirn-Struktur); B-Zell-Lymphom: plötzlich Knoten/Tumor ; LZ in Dermis/Bottm-Down; Kontrollen nötig;			Biopsie, Molekularbio (Monoklonalität)	Prognose bei allen gut ausser bei Sézary-Sy. sehr schlecht.
Granulomat. Hauterkrnakungen	Granuloma anulare: bengine selbstlimitierende granuomat. Dermatoe, Ursache unklar; Hautfarbene darbe ringfoermige dermale Papeln im Kreis angeordnet (im Mitte nichts), sieht aus wie Pilz, meist Haende/Fuesse; Wait + see , top. Steroide Sarkoidose: Braeunlich-erythematoeose Papeln, Plaques, anulaer od. knotig (bei jedem Pat. anders); Steroide, Immunsuppr., Cholorquin, Biologica Necrobiosis lipoidica: Flache plattenartige roetlich-gelblich-braeunliche Laesionen mit Atrophie, oft Ulzera, oft DM; Hartnäckig! Steroide Cheilitis granulomatosa/orofasziale Granulomatose: Schwellung d. Lippen, mehrere Tage, chronisch, geht fast n. weg! Melkersson-Rosenthal-Syndrom (Parotisschwellung, Fazialisparese, Cheilitis granulomatosa, Lingua plicata) Lepra: Trockenheit, Anhidrose, Alopezie, Hyaesthesie, Hypopgimentierung, Verdickung v. Nerven + Sz.; Multichemoth. (mehrer Jahre!), Reha Kutane TbC: diverse Veränderungen, Granulome Kutane Leishmanniose: Stich >Rötung >juckende Papeln >Ulkus			Biopsie, Abstrich, BE	<u>Leishmanniose:</u> Protozoen via Sandfliegen, Mittelmeehrraum <u>Lepra:</u> M. leprae, tuberkuloide (besser) vs. lepromatöse Form.
Nävus/Mutterlmal (melanozytär)	N. pigmentosus et pilosus: angeboren, braun, behaart, kann riesig werden Mongolenfleck: bläulich, oft Rücken/Gesäss/Sacrum, angeboren, verschwindet bis Pubertät *Cafe-au-Lait-Flecken: hellbraune Hautflecken, am ganzen Körper möglich, benigne Nävus Ota: wangenbereich (oft Areal v. V1/V2), z.T. in Sklera auch, lebenslang Nävus Ito: lebenslang, flache Hypertigment. an Schulter, behaart Nävus bleu: blaue Frabe (weil tief in Dermis), Nävus Spitz: nicht-pigment., eher rötlich wie Papel, Kinder + Jugendliche, wächst schnell, meist Gesicht Nävus spilus: sieht aus wie Schmutziger Fleck, einzelne Naevi in Cafe-au-Lait-Fleck Nävus Sutton: Depigmentierte Zone (ganz hell) rund um Nävus *Epheliden/Sommersprossen: kl. gelblich-braune Nävi, oft bei blonden/rothaarigen Pers., Pigmentablagerung durch Sonne, im Sommer stärker, via Laser entfernbar, Melanosis neurocutanea: Badehosennävus (oft lumbal), pigmentierte Fläche mit Haaren, z.T. auch in Meningen/WS, Melanom möglich! *Lentigo simplex/Leberfleck: entsteht meist in Kindheit an sonnenxp. Stellen, kl. flache braune Maculae *Lentigo solaris/senilis/Alterflecken: lokale scharf-begr. braune Maculae an sonnenexp. Haut wegen chron. UV-Strahlung, Handrücken/Gesicht/Arme, Laser od. Vit-A-Th. einfache Entfernung, benigne.		<u>Anamnese:</u> erworben od. kongenital, Veränderung (Grösse, Farbe, etc.), Sonne, FA, B-Symptome <u>Status:</u> Inspektion (Farbe, Erhabenheit, Grösse, Rand, Dicke, Beweglichkeit), ganzes Integument inspizieren	Sonnenschutz, Kontrollen Derma, ev. Biopsie Keine Therapie	<u>Nävus:</u> benigne Prolf. v. Melanozyten, kann in Entarten (Melanom). Erworben od. Kongenital, epidermal od. dermal *gehören eigentlich nicht zu Nävi weil keine Melanozytenprofliferate sondern einfach Hyperpigmentierung.
Malignes Melanom	Vorläsion, Veränderung (Grösse, Farbe, etc.), Sonne, FA, B-Symptome RF: viele Nävi, heller Hauttyp, FA, grosse cong. Nävi, Sonne, Solarium	<u>Haut:</u> ABCDE-Regel (Asymmetrie, Border, Colour, Diameter, Evolution/Veränderung), ganze Haut inspizieren (inkl. Kopfhaut, Nägel, Fusssohle, alles), Hauttyp bestimmen <u>Schleimhäute:</u> Mund, Genitale	Dermatoskopie (Lupe) Biopsie (Exzision od. Stanz falls gross) <u>Präoperativ:</u> Staging via CT (Metastasen) + SLK -Bestimmung	1. Chirurgie ausser bei Metastasen 2. Kontrollen 1. <u>Melanoma in situ/invasives Melanom ohne Metastasen/Lentigo maligna:</u> Chirurg. Exzision , falls SLK+ >totale regionäre Lymphadenektomie 2. <u>Metastasierendes Melanom:</u> ev. palliative	Lentigo maligna (kann zu Melanom werden, übermässige UV/Sonne, Gesicht/Arme/Hals, braune unregelm. Hyperpigment. Mit unregelm. Rand) <u>Vorkommen:</u> überall Haut + Schleimhaut! Achtung nicht immer pigmentiert!

				Exzision, ev. Chemo-RT	
Benigne Hauttumoren	Seborrhoische Warze/Alterswarze: schmutzig-gelb bis schwarze OF, an jeder Stelle möglich, erscheint ev. fettig, wie aufgeklebt, harmlos, rauhe keratotische OF (DD zu Naevus), oft Alte, kann jucken Dermatofibrom/Histiozytom: hautfarben, weiches Anhängsel, oft am Hals + Achseln, auch hart-derbe braune verbackene Knötchen möglich, benigne, zieht s. zusammen wenn man an Haut zieht, oft nach Insektenstich Weitere: Lipom , Keloide (Narbenüberschuss), Hämangiom/Pinta rubis (oft in Form eines kl. roten Pünktchens, Alte!)				Keine Th. nötig, Exzision auf Wunsch
Präkanzerosen (Gefahr Progression zu Spinaliom bzw. L. maligna >Melanom)	Aktinische Keratose: solare/senile Keratose, Sonnenexponierte Haut beim Erw., heller Hauttyp, rötlich-braune unregelmässige fest haftende Hyperkeratose auf rötlicher Plaque, oft mehrere, Gesicht/Kopf/Hände/Arme Aktinische Cheilitis: Aktin. Keratose an Lippen Lentigo maligna: Ca in situ (Vorstufe Melanom), sonnexp. Haut (Gesicht, Hände, Hals), unregelm. landkartenart. Flache braune (versch. Farben) scharfbegr. Areale, >50 M. Bowen: Ca in situ (intraepid., Vorstufe Spinaliom), pers. rote schuppige krustös belegene Plaque, scharf-begr., therapieresistenz, jede Körperstelle möglich (auch genital), v.a. aber wo Sonne, >50 i.d.R. Erythroplasie Queyrat: analog M. bowen aber genital/oral, Ursache HPV, Vorstufe Spinaliom, dunkelroter weicher Herd, leicht verletzlich, schreitet schnell fort Leukoplakie: weissliche haftende Verdickung in Schleimhaut (oral, genital), RF chron. Reize (Rauchen, Alk, Prothese...)			<u>Anamnese:</u> Vorläsion, Veränderung (Grösse, Farbe, etc.), Sonne, Photodyn. Th., Beruf, Rauchen, Alk, FA, B-Symptome <u>Status: ABCDE-Regel</u> (Asymmetrie, Border, Colour, Diameter, Evolution/Veränderung), ganze Haut inspizieren (inkl. Kopfhaut, Nägel, Fusssohle, alles), Hauttyp bestimmen LK! Schleimhäute <u>Untersuchungen</u> Dermatoskopie, ev. Biopsie	AK: Kryotherapie; Curettage, Efudix (Zytotox. Medi), Imiquimod (Aldara), Phototh. L. maligna: Exzision M. Bowen: Kryo, Efudix, Phototh., Exzision Erythropl. Q: Exzision, Laser Leukoplakie: Reiz beseitigen (oft Besserung), sonst Exzision
	Maligne Hauttumoren (mesenchymal, ephithelial)	Spinaliom/PE-Ca: v.a. Alte (70-80), sonnexp. Areale, derb-harter hautfarbener Herd, verhornend, unrgelm. OF, ev. Knotenbildung od. geschwüriger Zerfall, auch an Schleimhäute (Lippen, Penis, Vulva, Anal, Zunge, Mundhöhle) Basaliom/Basalzell-Ca: sonnexp. Stellen (Gesicht), >50 v.a., keine Vorläufer-Läsion, falls sklerodermiformes B. kann es narbenartig + s. hell sein Melanom: ist melanozytären Ursprungs (Nävi), siehe oben M. Paget: an Brustwarze, intraepidermal wachsendes intraduktales Adeno-Ca >v.a. Frauen ab 40, Mamma-Ca suchen! Metastasen			Spinaliom: Exzision, RT Basaliom: Exzision, RT, falls oberfl. Basaliom: Kryoth., Photodyn. Th., zyttox. Agentien (Efudix), Imiquimod/Aldara Melanom: Exzision (Sicherheitsabst.) Wichtig: Präkanzerosen auch behandeln, Prävention (Lichtschutz!)
Brauner Hauttumor DD DD: Melanom, Nävus (n. erhaben, oft schon in jungen J.), Fibrom (unter Haut), Basaliom, Seb. Keratose,					